

· 流行病学研究 ·

中国 11 省市青少年性与生殖健康知识、态度及行为调查



赵芮¹, 张磊², 富晓星³, 苏春艳⁴, 张玉萍⁵

【摘要】目的 了解 11 省市青少年性与生殖健康相关知识、态度和行为现状, 为促进学校生殖健康教育提供数据支持。**方法** 于 2017 年 6—8 月, 在中国 11 省市便利抽取 22 所高中和 21 所大学的 1 355 名学生, 采用自行设计的健康问卷开展横断面调查。**结果** 青少年的性与生殖健康知识及格率仅为 53.28 %。青少年的性观念和性行为开放, 仅有 25.98 % (352/1 355) 的青少年认为婚前不应该有性行为, 8.98 % (52/579) 的未成年组学生、10.85 % (83/765) 的高中生及 26.61 % (157/590) 的大学生有过性经历; 过去 1 年内, 高中生发生酒后性行为 and “约炮” 行为的比例均显著高于大学生 ($\chi^2 = 7.888\ 4$ 、 $10.382\ 7$, 均 $P < 0.05$); 男性有性行为、看色情作品经历的比例均显著高于女性 ($\chi^2 = 34.529\ 2$ 、 237.760 , 均 $P < 0.001$)。在校期间没有学习过关于艾滋病、孕产与性传播疾病和生理健康知识的青少年分别占 36.16 % (490/1 355)、70.26 % (952/1 355)、39.78 % (539/1 355)。**结论** 青少年性与生殖健康知识的了解水平整体偏低, 性观念与性行为开放, 性行为趋向低龄化, 男性性风险高于女性, 学校应加强性与生殖健康教育力度和卫生服务可得性, 促进青少年健康发展。

【关键词】 艾滋病; 性与生殖健康; 青少年

中图分类号: R 179 文献标志码: A 文章编号: 1001-0580(2019)10-1330-09 DOI: 10.11847/zgggws1124531

Sexual and reproductive health related knowledge, attitude and behavior among senior high school and college students in 11 provinces and municipalities of China

ZHAO Rui*, ZHANG Lei, FU Xiao-xing, et al (*School of Sociology and Anthropology, Xiamen University, Xiamen, Fujian Province 361005, China)

【Abstract】Objective To examine sexual and reproductive health related knowledge, attitude and behaviors among adolescent students in China and to provide evidences for promoting reproductive health education in schools and universities. **Methods** We conducted a cross-sectional survey from June to August 2017 among 1 840 students recruited with convenient sampling from 22 senior high schools and 21 universities in 11 provinces and municipalities of China. A self-designed questionnaire was adopted in the study and totally 1 355 participants completed the survey via paper work or using mobile phone application anonymously. **Results** Of all the participants, 53.28% were scored with a pass mark of ≥ 60 out of 100 for sexual and reproductive health knowledge; only 25.98% (352/1 355) considered that one should not have sex before marriage, indicating an open attitude towards sexual behavior. Among the participants, sexual experience was reported by 8.98% (52/579) of those under the age of 18, 10.85% (83/765) of senior high school students, and 26.61% (157/590) of the college students; the senior high school students reported significantly higher sexual behaviors and calling someone for sex after alcohol drinking during previous one year than the college students ($\chi^2 = 7.888\ 4$ and $\chi^2 = 10.382\ 7$, both $P < 0.05$). The proportions of having sexual experiences and browsing pornographic materials were significantly higher among the male participants than among the female participants ($\chi^2 = 34.529\ 2$ and $\chi^2 = 237.760$, both $P < 0.001$). For all the participants, 36.16% (490), 70.26% (952), and 39.78% (539) did not reported having education program on AIDS, maternity and sexually transmitted diseases, and physical health in the schools. **Conclusion** Among senior high school and college students in China, sexual and reproductive health knowledge is generally at a low level but the attitude towards sexual behavior is relatively open and sexual behavior tends to be prevalent in younger students, especially among male students; the results suggest that education programs on sexual activity and reproductive health and the accessibility of relevant health services need to be promoted among the students.

【Key words】 AIDS; sexual and reproductive health; adolescents

作者单位: 1. 厦门大学社会与人类学院人类学与民族学系, 福建 厦门 361005; 2. 西安交通大学公共卫生学院中澳传染病联合研究中心; 3. 中国人民大学; 4. 中国社会科学院大学; 5. 中国玉润公益基金会

作者简介: 赵芮 (1983—), 女, 黑龙江鸡西人, 助理研究员, 博士, 主要从事社会医学与医学人类学工作。(张磊为本文并列第一作者)

通信作者: 富晓星, E-mail: fuxiaoxing@126.com

数字出版日期: 2019-08-06 13:25

数字出版地址: <http://kns.cnki.net/kcms/detail/21.1234.R.20190806.1325.008.html>

长期以来性与生殖健康和权利(sexual and reproductive health and rights, SRHR)被视为一系列孤立的健康问题,很少认识到它们对人们整体健康和福祉的重要性^[1]。青少年的性与生殖健康问题尤其容易被忽视^[2]。据世界卫生组织统计,婚前性行为、未婚少女意外妊娠和性传播疾病、艾滋病蔓延是青少年性健康的几大重要问题。中国拥有世界上最大的青少年人口,2017 年 15~24 岁人口占总人口 11.6%,已经超过 13 243 万人。性与生殖健康问题不仅可能会对青少年的生活产生长期的负面影响,给其带来巨大的身体和心理伤害,甚至可能导致贫穷,给国家带来巨大的医药经济负担。本研究于 2017 年 6—8 月对中国 11 个省市 1 355 名青少年进行性与生殖健康知识、态度与行为现状调查,希望通过调查,评价青少年性与生殖健康服务的可得性和质量,为有针对性的健康教育计划提供数据支持。

1 对象与方法

1.1 对象 于 2017 年 6—8 月,采用便利抽样方法,从中国德兰光明慈善基金会协作教育网络中的东中西部(此处指通用的经济地带,非地理概念)11 省市——黑龙江、河北、湖南、浙江、福建、广东、广西、四川、海南省和北京、天津市抽取 22 所高中和 21 所大学年龄在 14~25 岁的高中生和大学生(下文中的“青少年”指满足以上调查对象条件的高中生和大学生统称)进行横断面问卷调查。每个省至少包括 1 所学校,调查组与学校管理部门取得联系,充分告知研究目的和研究内容,经过对方同意,随机抽取每个年级的 1 个班/系,之后进入班级获得受访对象的知情同意后完成问卷调查工作。问卷回收共计 1 840 份(1 002 份高中生问卷,838 份大学生问卷),不完整的问卷和不一致的问卷被排除在进一步的分析之外,最终得到有效问卷 1 355 份,有效问卷率为 73.64%。

1.2 方法 本研究获得清华大学公共健康研究中心伦理审查委员会的批准(注册号:009),向所有参与者均提供了书面同意书。问卷调查工作由班主任/辅导员负责组织学生参与调查,每位调查员负责采用面对面的方式完成调查访谈,除非有学生选择退出,否则这个班的所有学生均被邀请参加调查。如果参与者感到不舒服,他们可以随时退出调查。受访对象可使用纸质问卷匿名填答,亦可现场采用手机扫描二维码电子问卷填答,问卷当场收回。本次调查参照相关文献报告^[3-6]自行调整编制调查问卷。问卷由 4 部分组成:(1)人口统计学特征,主要

包括性别、年龄、民族、宗教信仰、年级、居住情况、生活费来源等;(2)艾滋病知识,主要包括人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)与艾滋病的关系、HIV 病毒的传播感染方式(母婴、血液、咳嗽、蚊虫叮咬、与 HIV 病毒携带者接吻拥抱、共饮一杯水、共用针具、无保护措施性交/口交等)、HIV 病毒潜伏时间以及预防方式等知识;(3)孕产和性传播疾病知识,主要包括避孕途径及其获取方式、影响生育能力的因素以及常见性传播疾病知识;(4)性行为和态度,包括性取向、首次手淫年龄、是否看过色情制品及获取途径、时间,是否有过性行为、在过去 1 年内是否有过“约炮”行为(属于随意的或非承诺的非伴侣性行为,此行为带有强烈的性行为或性交意图)、在过去 1 年内是否有过酒精后性行为 and 吸毒后性行为、在校是否学习过相关课程、是否支持同性恋及同性婚姻合法化等。知识及格率判定,性与生殖健康知识包括艾滋病知识、孕产和性传播疾病知识,将 23 道知识问答题目以百分制得分,计算调查对象的知识得分,60 分以上为及格,反之不及格。

1.3 统计分析 运用数据处理软件 Epi Data 3.1 录入并建立数据库,采用 Stata 14.0 统计软件进行一般性描述性统计,单因素分析主要采用 χ^2 检验, $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 基本人口学特征 本次调查 14~25 岁青少年共 1 355 人,平均年龄(18.27 ± 1.85)岁,其中高中生平均年龄(16.99 ± 1.01)岁,大学生平均年龄(19.94 ± 1.30)岁。其他特征详见表 1。

2.2 青少年性与生殖健康知识和态度

2.2.1 青少年性与生殖健康知识及格率影响因素分析(表 2) 调查显示,青少年性与生殖健康知识的掌握水平普遍偏低,总知识平均得分 58.56 分,及格率仅为 53.28%(722/1 355)。性别、年龄、教育程度、宗教、居住方式、性取向和在校学习相关课程是知识及格率的重要影响因素。随着年龄和受教育程度的提高,知识及格率也显著增高。无宗教信仰、性取向为双性恋和同性恋的学生及格率显著高于有宗教信仰和异性恋个体。居住方式方面,在高中与父母同住的学生及格率显著高于住校和其他居住形式的学生,在大学三者差异无统计学意义。学校性与生殖健康教育与知识及格率呈显著正相关。高中女性知识及格率显著高于男性,但大学男性知识及格率显著高于女性。

表 1 调查对象社会人口学特征

变量	合计(<i>n</i> = 1 355)		高中(<i>n</i> = 765)		大学(<i>n</i> = 590)	
	人数	%	人数	%	人数	%
性别						
男性	593	43.76	369	48.24	224	37.97
女性	762	56.24	396	51.76	366	62.03
年龄(岁)						
14 ~ 17	579	42.73	562	73.46	17	2.9
18 ~ 25	776	57.27	203	26.54	573	97.1
民族						
汉族	1 248	92.10	716	93.59	532	90.17
少数民族	107	7.90	49	6.41	58	9.83
教育						
高中	765	56.46	765	56.46		
大学	590	43.54			590	43.54
宗教信仰						
佛教	201	14.83	113	14.77	88	14.92
道教	21	1.55	10	1.31	11	1.86
基督教	26	1.92	13	1.70	13	2.20
伊斯兰教	5	0.37	2	0.26	3	0.51
其他宗教	178	13.14	78	10.20	100	16.95
无宗教信仰	924	68.19	549	71.76	375	63.56
居住情况						
与父母居住	479	35.35	391	51.11	88	14.92
与父亲居住	18	1.33	14	1.83	4	0.68
与母亲居住	36	2.66	29	3.79	7	1.19
住学校	758	55.94	288	37.65	470	79.66
寄宿亲戚家	17	1.25	14	1.83	3	0.51
其他	47	3.47	29	3.79	18	3.05
经济来源						
父母	1 289	95.13	742	96.99	547	92.71
亲戚朋友	20	1.48	9	1.18	11	1.86
勤工俭学	227	16.75	42	5.49	185	31.36
奖助学金	87	6.42	28	3.66	59	10.00
其他	97	7.16	31	4.05	66	11.19
家庭状况						
原生家庭	1 204	88.86	684	89.41	520	88.14
组合家庭	49	3.62	28	3.66	21	3.56
离异家庭	79	5.83	44	5.75	35	5.93
其他	23	1.70	9	1.18	14	2.37

表 2 青少年性与生殖健康知识及格率单因素分析(*n* = 1 355)

变量	青少年知识及格情况(<i>n</i> = 1 355)				高中生知识及格情况(<i>n</i> =765)				大学生知识及格情况(<i>n</i> = 590)			
	人数	%	χ^2 值	<i>P</i> 值	人数	%	χ^2 值	<i>P</i> 值	人数	%	χ^2 值	<i>P</i> 值
性别			1.198 6	0.274			10.477 4	0.001			7.255 8	0.007
男性	306	51.60			159	43.09			147	65.63		
女性	416	54.59			217	54.80			199	54.37		
年龄(岁)			27.352 7	0.000			15.744 8	0.000			0.234 7	0.628
14 ~ 17	261	45.08			252	44.84			9	52.94		

续表 2

变量	青少年知识及格情况(<i>n</i> = 1 355)				高中生知识及格情况(<i>n</i> =765)				大学生知识及格情况(<i>n</i> = 590)			
	人数	%	χ^2 值	<i>P</i> 值	人数	%	χ^2 值	<i>P</i> 值	人数	%	χ^2 值	<i>P</i> 值
18 ~ 25	461	59.41			124	61.08			337	58.81		
民族			0.160 8	0.688			1.454 9	0.228			1.960 3	0.161
汉族	663	53.13			356	49.72			39	67.24		
少数民族	59	55.14			20	40.82			307	57.71		
教育			12.061 1	0.001			12.061 1	0.001			12.061 1	0.001
高中	376	49.15			376	49.15						
大学	346	58.64							346	58.64		
宗教信仰			21.493 9	0.000			21.955 1	0.000			5.166 0	0.023
有宗教信仰	190	44.08			77	35.65			113	52.56		
无宗教信仰	532	57.58			299	54.46			233	62.13		
居住情况			12.237 6	0.002			20.385 1	0.000			4.816 7	0.090
与父母居住	267	55.74			222	56.78			45	52.14		
住学校	410	54.09			124	43.06			286	60.85		
其他	45	38.14			30	34.88			15	46.88		
家庭状况			4.218 5	0.239			2.240 1	0.524			2.821 1	0.420
原生家庭	649	53.90			341	49.85			308	59.23		
组合家庭	28	57.14			14	50.00			14	66.67		
离异家庭	36	45.57			18	40.91			18	51.43		
其他	9	39.13			3	33.33			6	42.86		
性取向			21.512 9	0.000			18.828 0	0.000			3.944 9	0.267
异性恋	609	55.11			322	51.60			287	59.67		
同性恋	11	57.89			5	55.56			6	60.00		
双性恋	45	60.81			23	57.50			22	64.71		
不确定	57	36.31			26	28.26			31	47.69		
在学校是否学习过艾滋病知识			86.550 4	0.000			43.591 1	0.000			47.780 2	0.000
是	543	62.77			291	52.74			252	69.81		
否	179	36.53			85	32.57			94	41.05		
学校是否开设生理健康课程			14.477 3	0.000			15.997 7	0.000			0.883 0	0.347
是	469	57.48			246	55.28			223	60.11		
否	253	46.94			130	40.63			123	56.16		
是否学习过避孕流产相关知识			96.020 6	0.000			68.942 9	0.000			35.422 5	0.000
是	297	73.70			180	70.31			117	79.59		
否	425	44.64			196	38.51			229	51.69		
在家中父母是否与您聊过性相关知识			3.315 4	0.069			4.829 4	0.028			0.107 7	0.743
是	188	57.67			106	56.08			82	59.85		
否	534	51.90			270	46.88			264	58.28		

2.2.2 青少年艾滋病知识与态度影响因素分析(表 3)

在艾滋病知识方面,青少年对艾滋病与 HIV 病毒的关系、艾滋病传播途径、防止感染 HIV 病毒知识很不乐观。50.41 %(683/1 355)的青少年分不清 HIV 病毒与艾滋病的关系。只有 18.60 %(252/1 355)的人能够正确回答与 HIV 病毒携带者共饮一杯水、拥抱或者蚊虫叮咬、打喷嚏等行为不会感染 HIV 病毒。22.80 %(309/1 355)的学生不知道或不认为 HIV 病毒可以通过母婴传播。14.39 %(195/1 355)的学生认为只发生 1 次性行为不可能感染 HIV 病毒,28.56 %

(387/1 355)的学生对此表示不知道。12.84 %(174/1 355)的学生认为性行为之后清洗私处,可以避免感染 HIV 病毒,28.27 %(383/1 355)的学生对此表示不知道。只有 54.61 %(740/1 355)的学生知道使用安全套可以防止人们感染 HIV 病毒。在对艾滋病态度上,64.94 %(880/1 355)的青少年害怕艾滋病,27.08 %(367/1 355)的青少年认为艾滋病患者或者感染 HIV 病毒的人应该被隔离。单因素分析发现,性别、民族、学校和家庭性相关教育、性与生殖健康知识得分是影响艾滋病态度的主要因素。女性、

少数民族学生比男性、汉族学生更加害怕艾滋病。

性知识的个体更加害怕艾滋病;性与生殖健康知识

在校学习过性与生殖健康知识或在家与父母聊过

得分越高的个体越害怕艾滋病。

表 3 青少年对同性恋态度单因素分析($n=1\,355$)

变量	害怕		中立		不怕		χ^2 值	P 值
	人数	%	人数	%	人数	%		
性别							6.384 1	0.041
男性	365	61.55	173	29.17	55	9.27		
女性	515	67.59	197	25.85	50	6.56		
年龄(岁)							5.247 7	0.073
14~17	363	62.69	176	30.40	40	6.91		
18~25	517	66.62	194	25.00	105	8.38		
民族							9.580 4	0.008
汉族	796	63.78	351	28.13	101	8.09		
少数民族	84	78.50	19	17.76	4	3.74		
教育							2.170 1	0.338
高中	484	63.27	219	28.63	62	8.10		
大学	396	67.12	151	25.59	43	7.29		
宗教信仰							7.298 7	0.026
有宗教信仰	280	64.97	129	29.93	22	5.10		
无宗教信仰	600	64.94	241	26.08	83	8.98		
居住情况							11.146 5	0.025
与父母居住	324	67.64	108	22.55	47	9.81		
住学校	481	63.46	226	29.82	51	6.73		
其他	75	63.56	36	30.51	7	5.93		
家庭状况							2.618 9	0.855
原生家庭	787	65.37	327	27.16	90	7.48		
组合家庭	32	65.31	12	24.49	5	10.20		
离异家庭	47	59.49	25	31.65	7	8.86		
其他	14	60.87	6	26.09	3	13.04		
性取向							9.256 9	0.160
异性恋	728	65.88	292	26.43	85	7.69		
同性恋	8	42.11	7	36.84	4	21.05		
双性恋	48	64.86	20	27.03	6	8.11		
不确定	96	61.15	51	32.48	10	6.37		
在学校是否学习过艾滋病知识							20.064 1	0.000
是	582	67.28	204	23.58	79	9.13		
否	298	60.82	166	33.88	26	5.31		
学校是否开设生理健康课程							22.201 7	0.000
是	564	69.12	185	22.67	67	8.21		
否	316	58.63	185	34.32	38	7.05		
是否学习过避孕流产相关知识							25.883 3	0.000
是	280	69.48	77	19.11	46	11.41		
否	600	63.03	293	30.78	59	6.20		
在家中父母是否与您聊过性相关知识							6.273 5	0.043
是	218	66.87	75	23.01	33	10.12		
否	662	64.33	295	28.67	72	7.00		
知识及格							26.817 9	0.000
及格	504	69.81	155	21.47	63	8.73		
不及格	376	59.40	215	33.97	42	6.64		

2.2.3 青少年孕产、性传播疾病知识及态度 相比艾滋病知识,青少年对孕产、性传播疾病知识方面的了解程度相对高一些。72.28 % (553/765) 的高中生和 75.76 % (447/590) 的大学生知道 ≥ 3 种避孕途径,安全套、避孕药以及紧急避孕药是青少年知晓率最高的 3 种避孕方法。97.71 % (1 324/1 355) 的青少年认为服用避孕药对身体有副作用。但是, 57.78 % (783/1 355) 的青少年只知道 1 或 2 种常见性传播疾病(淋病、梅毒、艾滋病等)。20.39 % (156/765) 的高中生和 38.31 % (226/590) 的大学生表示有男/女朋友。仅有 25.98 % (352/1 355) 的青少年认为婚前不应该有性行为。20.22 % (274/1 355) 的青少年因为害怕怀孕选择回避发生性行为。“信任对方”是青少年选择不使用安全套的最主要原因。86.94 % (1 178/1 355) 的青少年认为人工流产对身体有危害,会影响以后的生育。4.38 % (26/593) 的男性认为人工流产是小事或者很正常,持此态度的女性仅占 1.31 % (10/762), 差异有统计学意义 ($\chi^2 = 13.186\ 0, P < 0.05$)。64.58 % (875/1 355) 的青少年想在 25 ~ 29 岁生孩子, 9.52 % (129/1 355) 的青少年不想生孩子。如果未婚怀孕, 17.79 % (241/1 355) 的青少年明确选择流产。母亲、好朋友、父亲则是青少年

认为怀孕时选择寻求帮助的主要 3 位对象。

2.3 青少年性取向与性行为 (表 4) 在性取向方面, 81.55 % (1 105/1 355) 青少年性取向为异性恋, 6.86 % (93/1 355) 的青少年性取向为同性恋或双性恋, 其中 14 ~ 17 岁学生认同为同性恋或双性恋的占 6.39 % (37/579), 18 ~ 25 岁的学生中该群体占 7.22 % (56/776), 11.59 % (157/1 355) 的学生不确定自己的性取向。在性行为方面, 青少年的性行为比较开放, 且趋于低龄化。8.98 % (52/579) 的未成年组学生、10.85 % (83/765) 的高中生及 26.61 % (157/590) 的大学生有过性经历。高中生“约炮”比例显著高于大学生, 高中生发生酒后性行为的比例亦显著高于大学生。男性有过性行为、看过色情制品的比例均显著高于女性, 其中 47.25 % (344/728) 的学生每周平均看 1 ~ 2 次, 通过手机电脑网络观看是最主要的方式。在有过性行为的学生中, 过去 1 年内, 男性因为喝酒发生性行为的比例显著高于女性; 过去 1 年内, 男性“约炮”的比例显著高于女性, “生理需要”、“寻找刺激”和“无聊寂寞”是学生“约炮”的主要原因。值得注意的是, 4 位大学生有过吸食毒品后发生性关系的经历, 14 位男生和 12 位女生有过被迫性交活动的经历。

表 4 不同性别与教育程度青少年性取向、恋爱经历与性行为情况 ($n = 1\ 355$)

变量	男性 ($n = 593$)		女性 ($n = 762$)		χ^2 值	P 值	高中 ($n = 765$)		大学 ($n = 590$)		χ^2 值	P 值
	人数	%	人数	%			人数	%	人数	%		
性取向					10.395 5	0.015					1.105 3	0.776
异性恋	490	82.63	615	80.71			624	81.57	481	81.53		
同性恋	11	1.85	8	1.05			9	1.18	10	1.69		
双性恋	20	3.37	54	7.09			40	5.23	34	5.76		
不确定	72	12.14	85	11.15			92	12.03	65	11.02		
现在是否有男/女朋友					5.647 0	0.059					55.170 9	0.000
有	174	29.34	208	27.30			156	20.39	226	38.31		
没有	378	63.74	521	68.37			569	74.38	330	55.93		
不确定	41	6.91	33	4.33			40	5.23	34	5.76		
是否有过手淫					440.726	0.000					6.815 9	0.009
是	360	60.71	58	7.61			258	33.73	160	27.12		
否	233	39.29	704	92.39			507	66.27	430	72.88		
是否看过色情制品					237.760	0.000					0.012 3	0.912
是	459	77.40	269	35.30			410	53.59	318	53.90		
否	134	22.60	493	64.70			355	46.41	272	46.10		
是否有过性行为					34.529 2	0.000					56.768 4	0.000
是	146	24.62	94	12.34			83	10.85	157	26.61		
否	447	75.38	668	87.66			682	89.15	433	73.39		
过去 1 年内是否有约炮经历					9.806 8	0.002					7.888 4	0.005
是	54	36.99	17	18.09			34	40.96	37	23.57		
否	92	63.01	77	81.91			49	59.04	120	76.43		
过去 1 年内是否有酒后性行为					9.013 0	0.003					10.382 7	0.001
是	43	29.45	12	12.77			29	34.94	26	16.56		

续表 4

变量	男性(<i>n</i> = 593)		女性(<i>n</i> = 762)		χ^2 值	<i>P</i> 值	高中(<i>n</i> = 765)		大学(<i>n</i> = 590)		χ^2 值	<i>P</i> 值
	人数	%	人数	%			人数	%	人数	%		
否	103	70.55	82	87.23	2.619 0	0.106	54	65.06	131	83.44	2.150 5	0.143
过去 1 年内是否有吸食毒品后发生性行为												
是	142	97.26	94	100.00			83	100.00	153	97.45		
否	4	2.74	0	0.00	0.597 5	0.440	0	0.00	4	2.55	0.769 0	0.381
过去 1 年内是否有被迫性交行为												
是	14	9.59	12	12.77			11	13.25	15	9.55		
否	132	90.41	82	87.23			72	86.75	142	90.45		

2.4 青少年同性恋态度影响因素分析（表 5） 高达 34.39 % (466/1 355) 的学生认为同性恋与异性恋群体无区别, 仅有 10.63 % (144/1 355) 的学生认为同性恋不正常。性别、民族、宗教、居住情况、学校和家庭性相关教育、知识得分是重要的影响因素。40.55 % (309/762) 的女性支持同性恋, 显著高于男

性。与父母生活在一起的学生支持率更高。知识得分越高、在校学习过性与生殖健康知识和在家与父母聊过性知识的个体均更加支持同性恋。但是, 男异性恋者、少数民族学生和有宗教信仰的学生相对保守, 持反对态度的比例更高。

表 5 青少年对同性恋态度单因素分析(*n* = 1 355)

变量	支持		中立		反对		χ^2 值	<i>P</i> 值
	人数	%	人数	%	人数	%		
性别							33.639 8	0.000
男性	157	26.48	354	59.70	82	13.83		
女性	309	40.55	391	51.31	62	8.14		
年龄(岁)							4.177 0	0.124
14 ~ 17	195	33.68	311	53.71	73	12.61		
18 ~ 25	271	34.92	434	55.93	71	9.15		
民族							8.259 5	0.016
汉族	430	34.46	694	55.61	124	9.94		
少数民族	36	33.64	51	47.66	20	18.69		
教育							3.140 1	0.208
高中	267	34.90	408	53.33	90	17.76		
大学	199	33.73	337	57.12	54	9.15		
宗教信仰							18.979 8	0.000
有宗教信仰	115	26.68	257	59.63	59	13.69		
无宗教信仰	351	37.99	488	52.81	85	9.20		
居住情况							21.786 9	0.000
与父母居住	203	42.38	234	48.85	42	8.77		
住学校	231	30.47	440	58.05	87	11.48		
其他	32	27.12	71	60.17	15	12.71		
家庭状况							2.618 9	0.855
原生家庭	407	33.80	666	55.32	131	10.88		
组合家庭	20	40.82	26	53.06	3	6.12		
离异家庭	33	41.77	39	49.37	7	8.86		
其他	6	26.09	14	60.87	3	13.04		
性取向							91.621 3	0.000
男异性恋	121	24.69	303	61.84	66	13.47		
女异性恋	233	37.89	335	54.47	47	7.64		
男同性恋	9	81.82	1	9.09	1	9.09		

续表 5

变量	支持		中立		反对		χ ² 值	P 值
	人数	%	人数	%	人数	%		
女同性恋	6	75.00	2	25.00	0	0.00		
双性恋	51	68.92	19	25.68	4	5.41		
不确定	46	29.30	85	54.14	26	16.56		
在学校是否学习过艾滋病知识							18.708 6	0.000
是	333	38.50	441	50.98	91	10.52		
否	133	27.14	304	62.04	53	10.82		
学校是否开设生理健康课程							8.599 8	0.014
是	305	37.38	432	52.94	79	9.68		
否	161	29.87	313	58.07	65	12.06		
是否学习过避孕流产相关知识							51.081 8	0.000
是	195	48.39	180	44.67	28	6.95		
否	271	28.47	565	59.35	116	12.18		
在家中父母是否与您聊过性相关知识							13.967 3	0.001
是	135	41.41	150	46.01	41	12.58		
否	331	32.17	595	57.82	103	10.01		
知识及格							56.750 3	0.000
及格	314	43.49	343	47.51	65	9.00		
不及格	152	24.01	402	63.51	79	12.48		

2.5 青少年性与生殖健康教育情况 调查发现,学校的生殖健康教育普遍显得薄弱不足。34.12 % (261/765)的高中生和 38.81 % (229/590)的大学生表示在校期间没有接触过关于艾滋病的科普讲座或课程。66.54 % (509/765)的高中生和 75.08 % (443/590)的大学生没有学习过避孕及人工流产的相关知识。41.83 % (320/765)的高中生和 37.12 % (219/590)的大学生表示学校没有开设生理健康课程。而家庭性教育更是微乎其微,75.29 % (576/765)的高中生和 76.78 % (453/590)的大学生表示其家长从未与他们聊过关于性以及性病的知识。

3 讨 论

全生命周期为我国公共卫生行动提供了重要视角。在生命早期建立健康行为时,儿童和青少年更有可能采取健康行为并避免成年期的不健康行为。本次调查与其他调查结果类似^[6],目前青少年的性与生殖健康情况不容乐观。首先,青少年对艾滋病、孕产及性传播疾病的认知不够清晰,知识掌握水平普遍偏低。学校性与生殖健康信息与服务的可得性不足是造成这个问题的重要原因之一。有研究显示,学校干预活动可以显著提高知识得分和及格率^[7-8],我们在调查中也发现,在学校接受过艾滋病、生理健康和孕产等相关课程知识的个体可以更好地掌握性与生殖健康知识,提高对性传播疾病和危险的认知,这表明,教育机构是传播性与生殖健康信息的有效渠道。但仍有超过 1/3 的青少

年表示在校没有接受过关于艾滋病、孕产、性病或生理健康等课程。可见,学校提供的性与生殖健康课程仍颇显缺乏。学校是负责青少年发展的主要机构,如果学校能够针对健康结果在性别、教育程度、宗教信仰以及性取向等方面存在的差异,开展全面的、有质量的健康教育计划,加大性与生殖健康教育力度和卫生服务的可得性,可以帮助青少年建立终身健康的行为模式。另外,居住方式也是知识得分的影响因素。国内有研究显示,住校的中学生知识及格率更高^[7],但本次调查数据显示,高中与父母住在一起的学生知识及格率显著高于在校居住学生和其他居住方式学生,在大学三者差异则无统计学意义。导致高中群体居住方式与知识及格率差异的原因主要是与在学校接受艾滋病、孕产和生理等性与生殖健康知识相关,同时,还与家庭性教育相关。在与父母同住的高中生里,与父母聊过性知识的比例达 30.43 % (119/391),而住校学生与父母聊过性知识的仅占 17.01 % (49/288),其他居住情况的学生这一比例为 24.42 % (21/89)三者差异有统计学意义($\chi^2 = 16.062\ 6, P < 0.001$,家庭性教育与知识及格率呈显著正相关($\chi^2 = 4.829\ 4, P < 0.05$)。或许高中阶段的学生正处于青春期,对性与生殖健康知识有切身了解的需求,家庭性教育对学生性与生殖健康问题的认知是有积极作用的。

其次,调查显示,青少年的性观念和性行为较开放,性行为趋向低龄化,其中,有性行为经历者占调查总人数的 17.71 %,高于国内其他研究结果^[9-10],

超过三成以上的个体认为同性恋与异性恋人群无区别,支持同性恋;近 9 % 的未成年组学生有性经历,高中生的约炮、酒后性行为等不安全性行为均高于大学生。男性有性行为、约炮、看色情制品的比例均高于女性,男性的性风险显著高于女性。少数青少年有被迫性行为、吸食毒品后性行为等不安全性行为问题差异虽无统计学意义,但值得重视。这些行为会增加意外妊娠、感染艾滋病毒的概率,影响青少年日后健康和预期寿命。据 WHO 评估表明,中国青少年生育率自 2000 年以来一直上升,在 2015 年达到 6.2‰(15 ~ 19 岁女孩),因性和生殖卫生问题导致的残疾和过早死亡数量巨大且在不断增多^[11]。与其他研究发现类似,网络、影视作品、杂志、朋友是青少年获取性与生殖健康知识的主要途径^[12-14]。活跃自由的网络媒体成为健康信息服务新的参与者,使得性与生殖话题变得相对透明化,给学生更多了解性与生殖问题的机会,但这些途径提供的信息零碎混杂,甚至常常出现低俗色情、暴力犯罪的内容。有研究指出,中国三成青少年遭遇过网络色情信息骚扰,浏览器、广告或者游戏中不时跳出的色情信息难以控制^[15]。调查显示,高达 53.73 % 的青少年均看过色情作品,网络观看是最主要形式。可见,加强网络媒体监管机制,完善相应执行标准,建立一个权威的性与生殖健康知识网站,专门科普正规、准确的性与生殖健康信息,提高知识与服务的可获得性和可及性,十分必要。

此外,值得注意的是,同性恋学生有过性行为经历的比例达 52.63 % (10/19),双性恋学生有过性行为比例达 20.27 % (15/74)。近年来性传播已经成了艾滋病毒传播的主要途径,学生中出现的艾滋病感染者人数逐年上升^[16],2017 年有 3 077 例 14 ~ 25 岁青少年感染艾滋病,其中同性性传播的感染占 81.8 %^[17]。卫生政策制定者与教育工作者应该重视学生的性取向,更好地理解不同性别认同人群的需求,尽早开展艾滋病毒检测和筛查,提供有针对性的服务,进而降低感染艾滋病毒的风险。

本研究存在局限,为多省份的横断面调查,但部分样本有效率不高,东部地区样本偏大,中西部偏小,虽然区域变量在几个影响因素分析中的差异有统计学意义,但代表性不强。为此,本文未做区

域比较分析,今后的研究中,为客观分析中东西部青少年性与生殖健康差异问题,多省份、代表性强的的大样本研究有待于进一步探索。

志谢 感谢中国德兰光明慈善基金会陈艳、熊鹰、李占西、冯莉、何达、万素敏等志愿者的调查工作支持

参考文献

[1] Starrs AM, Ezeh AC, Barker G, et al. Accelerate progress-sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher-Lancet Commission[J]. *Lancet*, 2018, 391(10140): 2642-2692.

[2] 黄盈盈. 性/别框架下的“性与生殖健康”[J]. *探索与争鸣*, 2014(9): 32-34.

[3] Carey MP, Schroder KE. Development and psychometric evaluation of the brief HIV knowledge questionnaire[J]. *AIDS Education and Prevention*, 2002, 14(2): 172-182.

[4] Mitchell A, Patrick K, Heywood W, et al. 5th National Survey of Australian Secondary Students and Sexual Health 2013(ARCSHS Monograph Series No.97)[EB/OL].(2014-04). <http://www.Latrobe.edu.au/arcsch>.

[5] Kraus S, Rosenberg H. The pornography craving questionnaire: psychometric properties[J]. *Archives of Sexual Behavior*, 2014, 43(3): 451-462.

[6] 郑晓瑛,陈功,等. 中国青少年生殖健康可及性调查基础数据报告[J]. *人口与发展*, 2015, 16(3): 2-16.

[7] 赵瑞,武俊青,周颖,等. 上海市中学生性与生殖健康相关知识干预效果评价[J]. *中国公共卫生*, 2019, 35(6): 758-761.

[8] 王萍,潘新娟,吕姝焱,等. 洛阳市中学生性与生殖健康教育干预研究[J]. *中国学校卫生*, 2014, 35(12): 1976-1979.

[9] 罗健斌,杨燕君. 广州高年级大学生艾滋病知识知晓与性行为趋势[J]. *中国公共卫生*, 2019, 35(11): 1062-1064.

[10] 蔡永年,肖民扬,宋丽军,等. 云南省 2015 年青年学生艾滋病知识知晓率及相关性行为分析[J]. *中国艾滋病性病*, 2017, 23(11): 1062-1064.

[11] World Health Organization. World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, World Health Statistics Annual[R]. Geneva, Switzerland: WHO Document Production Services, 2017.

[12] Ghebreyesus TA, Kanem N. Defining sexual and reproductive health and rights for all[J]. *Lancet*, 2018, 391(10140): 2583-2585.

[13] 朱丹玲,马健,廖慧霞,等. 深圳市福田区中学生生殖健康知识来源及需求分析[J]. *中国妇幼卫生杂志*, 2017, 8(1): 35-38.

[14] 姜宁. 1002 名中学生性知识态度行为调查[J]. *中国校医*, 2012, 26(5): 50-52.

[15] 李培林,陈光金,张翼,等. 中国青少年网络使用与网络安全调查篇,引自《社会蓝皮书: 2019 年中国社会形势分析与预测》[R] 北京: 社会科学文献出版社, 2019.

[16] 吴尊友. 我国学校艾滋病防控形势及策略[J]. *中国学校卫生*, 2015, 36(11): 1604-1605.

[17] 艾防中心. 国家卫生健康委员会 2018 年 11 月 23 日例行新闻发布会[EB/OL]. (2018-11-23). http://ncaidc.chinacdc.cn/zxxw/mtsd3/201811/t20181123_197487.htm.